

Cuidado postoperatorio y complicaciones

1. Introducción y relevancia clínica

El período postoperatorio es una fase crítica del tratamiento quirúrgico, en la que el paciente puede evolucionar favorablemente hacia la recuperación o, por el contrario, desarrollar **complicaciones potencialmente mortales** si no se detectan y tratan precozmente.

El **cuidado postoperatorio** abarca desde el momento en que el paciente sale del pabellón quirúrgico hasta su recuperación completa, e incluye:

- Monitoreo hemodinámico y respiratorio.
- Control del dolor y la sedación.
- Balance hídrico, nutricional y metabólico.
- Detección temprana de complicaciones.

El éxito del manejo quirúrgico no depende solo de la técnica, sino de una **vigilancia postoperatoria rigurosa** y un manejo integral.

El **EUNACOM** enfatiza la **evaluación de signos de alarma, fiebre postoperatoria, infección de herida, atelectasia, trombosis venosa profunda (TVP)** y complicaciones específicas según el tipo de cirugía.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El trauma quirúrgico genera una **respuesta inflamatoria y metabólica sistémica** (similar al estrés fisiológico):

- **Aumento del cortisol, catecolaminas y citoquinas**, con hipermetabolismo, retención hídrica y catabolismo proteico.
- Disminución de la función pulmonar y gastrointestinal transitoria.
- Retención urinaria por efecto anestésico.

- Depresión del sistema inmune (mayor riesgo infeccioso).

Estas respuestas buscan preservar la perfusión tisular y facilitar la cicatrización, pero también predisponen a complicaciones si el equilibrio se rompe (hipovolemia, infección, íleo, trombosis).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El seguimiento clínico postoperatorio debe ser **metódico, dirigido y continuo**, centrado en:

3.1 Monitorización inmediata (primeras 24 horas)

Sistema	Aspectos a vigilar	Signos de alarma
Cardiovascular	FC, PA, PAM, PVC (si canal central), diuresis	Hipotensión, taquicardia, palidez, piel fría (hemorragia o shock)
Respiratorio	FR, SatO ₂ , ruidos respiratorios	Disnea, hipoxemia, cianosis, estridor (atelectasia, broncoespasmo, embolia, neumonía)
Renal	Diuresis (>0,5 mL/kg/h)	Oliguria, anuria
Gastrointestinal	Ruidos intestinales, distensión, náuseas	Íleo paralítico, fuga anastomótica
Neurológico	Nivel de conciencia, respuesta motora	Somnolencia excesiva, confusión, agitación
Herida quirúrgica	Dolor, drenajes, sangrado	Hematoma, seroma, sangrado activo

Temperatura	Control c/6 h	Fiebre precoz o persistente (infección, atelectasia)
--------------------	---------------	--

3.2 Clasificación del postoperatorio

- **Inmediato:** primeras 24 h (PACU o UCI).
- **Mediato:** 2°–5° día (fase de reactivación).
- **Tardío:** >5 días (recuperación y alta).

Cada fase tiene **complicaciones típicas**:

Tiempo	Complicaciones frecuentes
0–24 h	Hemorragia, shock, hipoxia, reacción anestésica
1–3 días	Atelectasia, fiebre, náuseas, íleo
3–7 días	Infección de herida, dehiscencia, trombosis venosa
>7 días	Abscesos, complicaciones sépticas, fuga anastomótica

3.3 Dolor postoperatorio

El dolor debe considerarse un signo vital más.

El manejo multimodal (AINEs, paracetamol, opioides, anestésicos locales) previene hipoventilación, hipertensión y retención urinaria.

- Dolor mal controlado → ↑ riesgo de atelectasia y trombosis.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Monitoreo básico

- Signos vitales cada 15–30 min en PACU, luego cada 4–6 h.
- Diuresis horaria: meta $\geq 0,5$ mL/kg/h.
- Balance hídrico: ingresos – egresos.
- Control de hemoglobina, electrolitos y glucemia.

Exámenes según sospecha

Sospecha	Exámenes indicados
Hemorragia / shock	Hemograma, hematocrito seriado, lactato, eco-FAST
Infección	Hemocultivos, PCR, procalcitonina, cultivo de herida
Trombosis / embolia	Dímero-D, ecodoppler, angioTAC pulmonar
Íleo / obstrucción	Rx abdomen, TAC abdomen
Insuficiencia renal	Creatinina, urea, orina completa

5. Tratamiento (según guías MINSAL / protocolos quirúrgicos)

El manejo postoperatorio se basa en 4 pilares:

A. Soporte general y monitorización

1. **Signos vitales:** vigilancia estrecha, especialmente las primeras 24–48 h.
 2. **Fluidos y balance hídrico:** mantener euvolemia (revisar balance diario).
 3. **Oxigenoterapia:** $\text{SatO}_2 > 94\%$.
 4. **Analgesia multimodal:** paracetamol + AINE $\pm$ opioide si necesario.
 5. **Antibióticos profilácticos:** suspender a las 24 h, salvo indicación terapéutica.
 6. **Movilización precoz:** previene atelectasia, trombosis y pérdida muscular.
 7. **Profilaxis tromboembólica:** heparina de bajo peso molecular (HBPM) + compresión neumática.
 8. **Profilaxis antiulcerosa:** en pacientes con estrés o AINEs prolongados.
 9. **Nutrición:** reinicio precoz de vía oral o enteral según tolerancia.
-

B. Complicaciones postoperatorias frecuentes y su manejo

1 ☐ Hemorragia

- **Causa:** fallo hemostático o sangrado de sutura.
 - **Clínica:** palidez, hipotensión, taquicardia, descenso del Hto.
 - **Diagnóstico:** hemograma, ecografía o TAC.
 - **Tratamiento:** fluidos, transfusión y revisión quirúrgica si sangrado activo.
-

2 ☐ Shock postoperatorio

- **Causas:** hemorragia, sepsis, cardiogénico o anafiláctico.
 - **Manejo:** soporte hemodinámico, fluidos, antibióticos, control del foco o reintervención.
-

3 ☐ Fiebre postoperatoria

Muy frecuente; puede ser benigna o signo de infección.

Clasificación clásica por días:

Día postoperatorio	Causa más probable	Ejemplo
1–2	Atelectasia o respuesta inflamatoria	Dolor torácico, hipoxia leve
3–5	Infección urinaria o flebitis	Catéteres, sonda vesical
5–7	Infección de herida quirúrgica	Eritema, calor, secreción purulenta
>7	Absceso intraabdominal / sepsis	Fiebre persistente, leucocitosis, dolor

□ Toda fiebre >38,5°C mantenida >48 h postcirugía debe investigarse.

Estudio inicial:

Hemocultivos, orina, Rx tórax, revisión de heridas y drenajes.

4 □ Complicaciones respiratorias

- **Atelectasia** (más frecuente): dolor, hipoventilación, fiebre leve.
 - Prevención: fisioterapia respiratoria, deambulación, analgesia adecuada.
- **Neumonía**: fiebre, tos, secreción purulenta, crepitantes.
 - Tratamiento: antibióticos dirigidos (según guía MINSAL: ceftriaxona + azitromicina).
- **Embolia pulmonar (TEP)**: disnea súbita, taquicardia, hipoxemia.
 - Diagnóstico: angioTAC pulmonar.

- Tratamiento: anticoagulación o trombólisis (según gravedad).
-

5 ☐ Complicaciones gastrointestinales

- **Íleo paralítico:** distensión, náuseas, ausencia de gases.
 - Prevención: analgesia no opioide, movilización precoz.
 - Tratamiento: ayuno, SNG, reposición de líquidos y electrolitos.
 - **Fuga anastomótica:** dolor abdominal, fiebre, taquicardia, salida de contenido por drenaje.
 - Sospecha → TAC con contraste oral.
 - Manejo: drenaje, antibióticos, reintervención si peritonitis.
 - **Hemorragia digestiva:** hematemesis o melenas → endoscopia o cirugía según caso.
-

6 ☐ Complicaciones urinarias

- **Retención urinaria:** por anestesia o dolor.
 - Manejo: sondaje intermitente o Foley temporario.
 - **Infección urinaria:** fiebre, disuria.
 - Profilaxis: retiro precoz de sonda vesical.
-

7 ☐ Complicaciones tromboembólicas

- **TVP:** dolor, edema, signo de Homans.
- **TEP:** disnea súbita, hipoxemia, taquicardia.
 - Prevención: movilización precoz, HBPM, compresión neumática.

- Tratamiento: anticoagulación (heparina → anticoagulante oral).

8 ☐ Complicaciones de la herida quirúrgica

Tipo	Características	Manejo
Hematoma / seroma	Aumento de volumen, dolor	Drenaje, compresión
Infección superficial	Eritema, calor, supuración	Drenaje + antibiótico
Dehiscencia parcial / total	Separación de bordes o evisceración	Cobertura estéril + cirugía urgente

- ☐ Factores de riesgo: desnutrición, obesidad, tos persistente, diabetes, infección previa.

C. Complicaciones metabólicas

- **Hiperglicemia:** frecuente en diabéticos y por estrés quirúrgico → control glicémico 140–180 mg/dL.
- **Hipokalemia / hiponatremia:** por pérdidas o dilución → reposición dirigida.
- **Síndrome de realimentación:** iniciar nutrición progresiva y monitorizar fósforo.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Incidencia aproximada	Pronóstico
Atelectasia	10–25%	Reversible, previene con fisioterapia

Infección de herida	5–15%	Depende de control local y antibióticos
TVP/TEP	1–2%	Mortalidad hasta 30% si no tratada
Fuga anastomótica	1–5%	Mortalidad hasta 50% si sepsis no tratada
Dehiscencia / evisceración	<1%	Requiere reintervención inmediata
Hemorragia postoperatoria	1–2%	Pronóstico variable según control

El pronóstico global depende de:

- Estado basal y nutricional.
- Tipo y magnitud de la cirugía.
- Control precoz de complicaciones.
- Calidad del monitoreo postoperatorio.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Fiebre postoperatoria día 1–2** → *atelectasia*; día 5–7 → *infección de herida*.
2. **Oliguria postoperatoria**: pensar primero en **hipovolemia** antes de falla renal.
3. **Movilización precoz y analgesia adecuada**: reducen 80% de las complicaciones respiratorias.

4. **Profilaxis tromboembólica** siempre que no haya sangrado activo.
 5. **Dolor mal controlado = riesgo de hipoventilación y neumonía.**
 6. **Dehiscencia súbita + salida de asas intestinales = evisceración** → cirugía urgente.
 7. **Fuga anastomótica:** sospechar ante fiebre + taquicardia + dolor abdominal.
 8. **Balance hídrico diario y control de electrolitos** son claves para prevenir complicaciones metabólicas.
-



Errores comunes

- Mantener “ayuno y suero” innecesariamente >48 h.
 - No iniciar fisioterapia respiratoria precoz.
 - Retirar drenajes o sondas sin evaluar criterios clínicos.
 - Ignorar fiebre postoperatoria persistente.
 - Usar antibióticos más de 24 h en profilaxis.
 - No valorar diuresis horaria ni signos de hipoperfusión.
 - No sospechar TEP ante disnea o taquicardia inexplicada.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **El cuidado postoperatorio riguroso** determina el éxito quirúrgico.
2. **Monitorizar signos vitales, diuresis y herida quirúrgica** permite detectar complicaciones tempranas.
3. **Fiebre postoperatoria:** temprana → atelectasia; tardía → infección.

4. **Prevención:** analgesia multimodal, movilización precoz, fisioterapia respiratoria, HBPM.
5. **Infección de herida** → drenaje + antibióticos dirigidos.
6. **Dehiscencia o evisceración** → manejo quirúrgico urgente.
7. **La nutrición y el control hídrico adecuados** reducen morbilidad y mortalidad.